リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年10月23日（金）

第42号　朝刊

きょうの紙面　▸廃用予防・RCT　▸脳卒中・上肢　▸嚥下・費用対効果　▸短信 8本

■ 廃用予防・RCT

急性期病棟に運動を足すと退院時のSPPBが3.2点高い

70歳以上47人。平均4回の院内運動でも、立ち上がりパワーとMMSEで差

入院した高齢者は、治療のために動く機会が減り、退院するころには歩く力が落ちていることがある。VIVIFRAILをもとにした運動を病棟で足すと防げるのかを調べたRCTだ。対象は高齢者急性期ケア（ACE）ユニットに入院した70歳以上の47人（平均83.1±5.1歳、女性33%）で、運動群と通常ケア群に割り付けた。

運動は筋力・パワーの練習、バランス、歩行で、入院中に平均4±2回行った。主要評価のSPPBは、退院時の群間差が3.18点（95%CI 1.3～5.1）で運動群が高かった。椅子からの立ち上がり時間は11.3秒短く、立ち上がりの最大パワーは1.45 W/kg高く、MMSEも2.16点高かった。解析は割り付け通り（ITT）だ。

ただし47人と少なく、信頼区間は広い。評価は入院時と退院時の2点だけで、退院後に差が続くかは分からない。それでも実施が平均4回にとどまる中で差が出たことは、回復期の前の急性期から離床や運動をどこまで標準にできるかを考える材料になる。



平均4回の運動でも差。ただし47人・退院時のみの評価。

出典 Age and Ageing ↗

数字で見る

47人
70歳以上の入院患者

3.18点
退院時SPPBの群間差

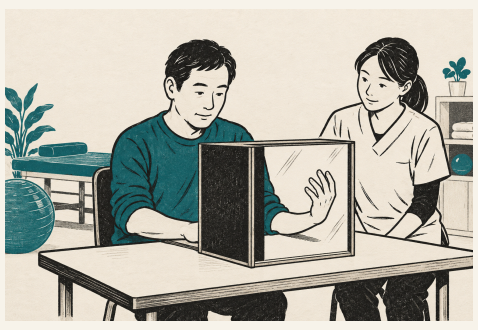
4回
入院中の運動（平均）

■ 脳卒中・上肢

鏡療法でFMA-UEが5.45点増 手指の根拠は弱い

脳卒中後の上肢に鏡療法を行ったRCT21本を統合した。Fugl-Meyer上肢スコア（FMA-UE）の合計は鏡療法で平均5.45点高く（95%CI 3.50～7.41）、異質性は低かった。一方、手指機能は1.16点（0.03～2.29）と小さく、感度分析では少数の重み付けの大きい研究に有意差が依存していた。

肩・肘・前腕は1.79点（−0.02～3.60）、手関節は0.65点（−0.17～1.47）



で、いずれも有意な差は示されていない。エビデンスの質は中～低で、著者も手指の結果は慎重に読むよう求めている。上肢全体のスコアか、手指の細かな機能かで期待を分けて評価したい。

出典 Frontiers in Neurology ↗

■ 嚥下・費用対効果

嚥下訓練の提供法を比較 ST対面は1QALY約12.4万€

中咽頭がんで（化学）放射線治療を受ける150人を、アプリ、STによる毎日の対面（20回）、紙と日誌の自己訓練の3群に割り付けたPRESTO試験の費用効果分析だ。EQ-5D-5Lの効用値に群間差はなく、費用はST対面が最も高く、アプリは紙より高いのに効用は同程度だった。紙とST対面の増分費用効果比は1QALYあたり12万4,061.54ユーロで、著者は毎日の対面は費用対効果が高くないと結論した。



同じ試験の主解析では、STと毎日訓練した群で実施率が高く、実施率が高いほど嚥下機能やQOLも改善していた。今回は二次解析で、費用は医療提供側の視点だ。どの患者に絞ってSTが関わるかが次の課題だ。

出典 Head & Neck ↗

短信

〈嚥下〉 **脳卒中後嚥下障害のリハ看護介入を比較**
17RCTのNMA。FOISではKT+NMESと呼吸筋訓練が上位。直接比較は未確認と著者が記載。 出典 JJNS ↗

〈心臓リハ〉 **ACS後の遠隔心臓リハ、センター型と同等**
129人RCT。8週の目標達成は86%対79.7%（P=0.37）。機能容量は両群で約1MET改善。 出典 Eur Heart J Open ↗

〈栄養・嚥下〉 **嚥下調整食の摂取率が高いほど転帰良好**
脳卒中406例の後ろ向き。摂取率10%増でmRS悪化の調整OR0.85。因果は言えない。 出典 Nutrients ↗

〈退院支援〉 **TBI退院後の遠隔支援、介護者負担は変わらず**
591組のRCT。6・12か月とも介護者の負担（Zarit）とQOLに群間差なし。 出典 J Neurotrauma ↗

〈回復期〉 **透析患者は脳卒中後のリハ転院が6.1%**
単施設1,173例。非透析は31.9%。透析とリハの両方を持つ施設が確保できなかった。 出典 Healthcare ↗

〈上肢〉 **BCI訓練、運動意図と同期した支援で上肢が改善**
亜急性期77人のRCT。FMA-UEは疑似より+7.47点、非同期より+9.72点高かった。 出典 J Neuroeng Rehabil ↗

〈急性期リハ〉 **脳卒中の急性期リハ、学会の臨床推奨を解説**
日本脳卒中学会。959施設の調査をもとに、発症24～48時間での離床を推奨している。 出典 No Shinkei Geka ↗

〈聴覚〉 **補聴器の使用者は全死亡リスクが9%低い**
個人データのメタ解析13,851人。HR0.91（0.83～0.99）。因果は言えない。 出典 Lancet Healthy Longev ↗